Tema: PATOLOGÍA MAMARIA

Subtema: CÁNCER DE MAMA (TAMIZAJE Y CLASIFICACIÓN)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Femenina de 52 años acude a su mastografía de tamizaje anual. No refiere síntomas ni se palpa nódulos. El reporte del radiólogo describe una zona de microcalcificaciones pleomórficas agrupadas en el cuadrante superior externo de la mama derecha, sin nódulos dominantes. El reporte concluye con una clasificación de BI-RADS 4.

Pregunta 1

De acuerdo con la conducta estipulada para la clasificación BI-RADS 4 (hallazgos sospechosos de malignidad), ¿cuál es el siguiente paso obligatorio en el abordaje de esta paciente?

A) Repetir la mastografía en 6 meses

B) Realizar un ultrasonido mamario y si es negativo, dar de alta

C) Realizar biopsia percutánea (trucut o guiada por estereotaxia) *

D) Iniciar tratamiento con tamoxifeno profiláctico

Retroalimentación:

La clasificación **BI-RADS 4** indica una sospecha de malignidad (que va del 2% al 95%). Por definición, cualquier lesión BI-RADS 4 o 5 requiere **confirmación histopatológica mediante biopsia**. El BI-RADS 3 es el que permite seguimiento a corto plazo (6 meses).

Pregunta 2

Si la biopsia reporta un Carcinoma Ductal In Situ, ¿cuál es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de cáncer de mama en la población general?

A) Tabaquismo y alcoholismo

B) Edad avanzada y ser mujer *

C) Uso de anticonceptivos orales por 1 año

D) Antecedente de lactancia materna prolongada

Retroalimentación:

Aunque existen factores genéticos (BRCA) y hormonales, los dos factores de riesgo más potentes y universales para cáncer de mama son el **sexo femenino** y el **aumento de la edad**.

Tema: LÍQUIDOS Y ELECTROLITOS EN CIRUGÍA

Subtema: REQUERIMIENTOS BASALES (REGLA 4-2-1)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Masculino de 70 kg que será sometido a una colecistectomía programada. El paciente debe permanecer en ayuno desde la medianoche. El cirujano solicita calcular la infusión de líquidos de mantenimiento (solución base) para las horas de ayuno preoperatorio.

Pregunta 1

Utilizando la regla clásica de Holliday-Segar (4-2-1) para el cálculo de líquidos de mantenimiento en adultos, ¿cuál es el ritmo de infusión horaria (ml/hr) ideal para este paciente de 70 kg?

A) 70 ml/hr

B) 100 ml/hr

C) 110 ml/hr *

D) 150 ml/hr

Retroalimentación:

La regla **4-2-1** se calcula así:

- Primeros 10 kg: 10 x 4 = 40 ml

- Segundos 10 kg: 10 x 2 = 20 ml

- Resto del peso (50 kg): 50 x 1 = 50 ml

Total: 40 + 20 + 50 = **110 ml/hr**. Una forma rápida en adultos de más de 20 kg es: Peso + 40 (70 + 40 = 110).

Tema: ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA (QUIRÚRGICA)

Subtema: HERNIA DE DISCO LUMBAR

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Masculino de 38 años, quien tras levantar un objeto pesado, presenta dolor lumbar súbito e intenso que se irradia por la cara posterior del muslo y pierna derecha hasta el talón. A la exploración física, presenta disminución del reflejo aquileo y debilidad para la flexión plantar. El signo de Lasègue es positivo a los 30 grados.

Pregunta 1

Por la distribución del dolor (ciática) y la pérdida del reflejo aquileo, ¿qué nivel de raíz nerviosa está probablemente comprimido por la hernia discal?

A) L3 - L4

B) L4 - L5

C) L5 - S1 *

D) T12 - L1

Retroalimentación:

La compresión de la raíz **S1** (frecuentemente por hernia en el espacio L5-S1) se manifiesta con dolor en la parte posterior de la pierna, afectación del **reflejo aquileo** y dificultad para caminar de puntillas (flexión plantar).

Tema: GASTROENTEROLOGÍA QUIRÚRGICA (ONCOLOGÍA)

Subtema: ADENOCARCINOMA DE PÁNCREAS

Dificultad: Alta

Caso clínico (Largo):

Masculino de 62 años, fumador crónico, acude por presentar **ictericia obstructiva progresiva** (tinte amarillento en piel y conjuntivas), coluria (orina oscura) y acolia (evacuaciones blancas). Refiere pérdida de peso de 10 kg en dos meses y dolor sordo en epigastrio que se irradia a la espalda. A la exploración física, se palpa una **vesícula biliar distendida, indolora** en el hipocondrio derecho (Signo de Courvoisier-Terrier).

Pregunta 1

La presencia de ictericia obstructiva y una vesícula palpable pero no dolorosa (Courvoisier-Terrier) en un paciente con pérdida de peso orienta fuertemente a una neoplasia periampular. ¿Cuál es el estudio de imagen inicial más útil para evaluar la cabeza del páncreas y la vía biliar?

A) Marcador tumoral CA 19-9

B) Tomografía Computarizada (TAC) multicorte con protocolo para páncreas *

C) Ultrasonido endoscópico

D) Radiografía de abdomen

Retroalimentación:

La **TAC abdominal con contraste** (protocolo pancreático) es el estándar para el diagnóstico y la evaluación de resecabilidad. Permite ver la masa, su relación con los vasos (arteria mesentérica superior y vena porta) y la dilatación de la vía biliar. El CA 19-9 es útil para seguimiento, pero no para diagnóstico inicial por su baja sensibilidad/especificidad.

Pregunta 2

Si el tumor se localiza en la cabeza del páncreas y no invade estructuras vasculares mayores, ¿cuál es el nombre de la técnica quirúrgica de elección con intención curativa?

A) Procedimiento de Puestow

B) Pancreatectomía distal con esplenectomía

C) Pancreatoduodenectomía (Operación de Whipple) *

D) Colecistectomía abierta

Retroalimentación:

La **operación de Whipple** es el tratamiento de elección para tumores resecables de la cabeza del páncreas. Consiste en la remoción de la cabeza del páncreas, el duodeno, la vesícula biliar, el conducto colédoco y, en ocasiones, parte del estómago, con la posterior reconstrucción digestiva.

Tema: ONCOLOGÍA QUIRÚRGICA

Subtema: SARCOMAS DE PARTES BLANDAS

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Masculino de 55 años acude por presentar una masa en el muslo derecho de crecimiento progresivo en los últimos 6 meses. La tumoración es profunda, de consistencia firme, no dolorosa y mide 10 cm de diámetro. No refiere antecedentes

de traumatismos. Se solicita una Resonancia Magnética que muestra una lesión voluminosa que desplaza los compartimentos musculares sin infiltrar hueso.

Pregunta 1

Ante la sospecha de un sarcoma de partes blandas por el tamaño y la profundidad de la lesión, ¿cuál es el procedimiento diagnóstico inicial de elección para obtener tejido y determinar el grado histológico?

A) Biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF)

B) Biopsia incisional con corte transversal

C) Biopsia por punción con aguja gruesa (Trucut) *

D) Resección marginal de la pieza completa

Retroalimentación:

La biopsia con aguja gruesa (Trucut) es el estándar inicial para el diagnóstico de sarcomas, ya que proporciona suficiente arquitectura tisular para el patólogo. La BAAF suele ser insuficiente para estos tumores. Es vital que el trayecto de la biopsia sea planeado de tal forma que pueda ser resecado durante la cirugía definitiva.

Pregunta 2

¿Cuál es el sitio más frecuente de metástasis a distancia de los sarcomas de partes blandas de las extremidades?

A) Hígado

B) Cerebro

C) Pulmón *

D) Ganglios linfáticos regionales

Retroalimentación:

La diseminación de los sarcomas es predominantemente hematógena, y el pulmón es el primer sitio de metástasis en la gran mayoría de los casos. Por ello, el protocolo de estadificación siempre incluye una TAC de tórax.

Tema: GASTROENTEROLOGÍA QUIRÚRGICA

Subtema: ACALASIA (TRATAMIENTO)

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Femenina de 34 años con disfagia progresiva tanto a sólidos como a líquidos de 2 años de evolución, acompañada de regurgitación de alimentos no digeridos y pérdida de peso de 5 kg. El esofagograma muestra una dilatación del cuerpo esofágico con una terminación distal afilada en pico de pájaro. La manometría confirma ausencia de peristalsis y relajación incompleta del esfínter esofágico inferior.

Pregunta 1

¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de elección (estándar de oro) para proporcionar alivio a largo plazo en pacientes jóvenes con acalasia idiopática?

A) Dilatación neumática con balón

B) Esofagectomía total

C) Cardiomiotomía de Heller laparoscópica con técnica de funduplicatura *

D) Inyección de toxina botulínica en el esfínter

Retroalimentación:

La miotomía de Heller (sección de las fibras musculares del esófago distal y cardias) asociada a un procedimiento antirreflujo parcial (como una funduplicatura de Dor o

Toupet) es el tratamiento quirúrgico preferido por su alta tasa de éxito y durabilidad. La toxina botulínica se reserva para pacientes con alto riesgo quirúrgico.

Tema: ATLS / QUEMADURAS

Subtema: QUEMADURAS QUÍMICAS

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Masculino de 24 años, empleado de una fábrica de limpieza, sufre salpicadura de un producto alcalino (lejía/sosa cáustica) en ambos brazos y tórax. Refiere dolor quemante intenso.

Pregunta 1

¿Cuál es la medida inicial más importante y prioritaria que debe realizarse en el lugar del accidente o a su llegada a urgencias antes de cualquier otra intervención?

A) Aplicación de una base débil para neutralizar el pH

B) Irrigación copiosa con agua corriente a baja presión *

C) Aplicación de ungüentos antibióticos y vendaje oclusivo

D) Desbridamiento inmediato de las flictenas

Retroalimentación:

En quemaduras químicas, especialmente por álcalis (que causan necrosis por licuefacción y penetran más profundo), el tratamiento fundamental es la irrigación inmediata y prolongada con agua (mínimo 20-30 minutos). Nunca se debe intentar neutralizar con otras sustancias químicas, ya que la reacción exotérmica resultante puede empeorar el daño térmico.

Tema: ATLS / TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO

Subtema: HEMATOMA SUBDURAL

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Masculino de 75 años, con antecedente de fibrilación auricular en tratamiento con warfarina. Sus familiares lo traen por presentar desorientación progresiva, somnolencia y debilidad en el lado derecho de 3 días de evolución. Refieren una caída trivial hace 2 semanas en la que se golpeó la cabeza pero no perdió el conocimiento.

Pregunta 1

Ante la sospecha de una colección intracraneal, se realiza una TAC de cráneo simple. ¿Cuál es el hallazgo imagenológico característico de un hematoma subdural?

A) Imagen biconvexa (en forma de lente) que no cruza suturas

B) Imagen en forma de semiluna (cóncavo-convexa) que puede cruzar suturas *

C) Sangre en las cisternas de la base y surcos corticales

D) Imagen en forma de sal y pimienta intraparenquimatosa

Retroalimentación:

El hematoma subdural se produce por la ruptura de las venas puente que van de la corteza a los senos venosos. En la TAC se observa como una colección en semiluna que sigue la convexidad del cerebro y, a diferencia del epidural, puede cruzar las líneas de las suturas craneales. Es común en ancianos y pacientes anticoagulados tras traumas aparentemente menores.

Tema: CIRUGÍA GENERAL

Subtema: TRÍADA DE LA MUERTE EN TRAUMA

Dificultad: Baja

Pregunta 1

En el manejo del paciente con trauma grave y hemorragia masiva, el cirujano debe evitar a toda costa la instauración de la tríada de la muerte (o tríada letal). ¿Cuáles son los tres componentes de esta tríada?

A) Hipertensión, bradicardia e hipotermia

B) Acidosis metabólica, hipotermia y coagulopatía *

C) Taquicardia, hipotensión y oliguria

D) Hipoxia, hipercapnia y acidosis

Retroalimentación:

La tríada letal consiste en acidosis, hipotermia y coagulopatía. Estos tres factores se alimentan entre sí en un círculo vicioso que lleva a la muerte del paciente a pesar del control quirúrgico de las lesiones. El manejo moderno del trauma (Cirugía de Control de Daños) se enfoca en corregir estos parámetros antes de realizar reparaciones definitivas complejas.

Tema: GASTROENTEROLOGÍA QUIRÚRGICA (ONCOLOGÍA)

Subtema: CÁNCER DE ESÓFAGO

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Masculino de 64 años, con antecedente de tabaquismo intenso y reflujo gastroesofágico de 20 años de evolución mal tratado. Acude por disfagia progresiva, inicialmente a sólidos y ahora a líquidos, de 3 meses de evolución, acompañada de pérdida de peso de 12 kg y dolor retroesternal. Se realiza endoscopia que muestra una lesión exofítica estenosante en el tercio distal del esófago. La biopsia reporta Adenocarcinoma.

Pregunta 1

Dado el antecedente de reflujo crónico y la localización en el tercio distal, ¿cuál es la condición premaligna que precedió con mayor probabilidad al desarrollo de este Adenocarcinoma?

A) Esófago de Barrett *

B) Acalasia de larga evolución

C) Síndrome de Plummer-Vinson

D) Ingesta de cáusticos en la infancia

Retroalimentación:

El Adenocarcinoma de esófago se asocia estrechamente con el reflujo gastroesofágico crónico y el Esófago de Barrett (metaplasia intestinal). Se localiza predominantemente en el tercio distal. Por el contrario, el Carcinoma Epidermoide (escamoso) se asocia a tabaco, alcohol y acalasia, y suele localizarse en los tercios superior y medio.

Pregunta 2

¿Cuál es el estudio de elección para realizar la estadificación local (profundidad de la invasión T y afectación de ganglios regionales N) en el cáncer de esófago?

A) Tomografía Computarizada (TAC) simple

B) Ultrasonido endoscópico (EUS) *

C) Tránsito esofagogástrico con bario

D) PET-CT de cuerpo completo

Retroalimentación:

El ultrasonido endoscópico es la herramienta más precisa para determinar la profundidad de la invasión en la pared esofágica (estadio T) y para identificar ganglios

linfáticos periesofágicos sospechosos (estadio N), lo cual es crucial para decidir si el paciente es candidato a cirugía inicial o neoadyuvancia.

Tema: CIRUGÍA PEDIÁTRICA / INTESTINO DELGADO

Subtema: DIVERTÍCULO DE MECKEL

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Paciente masculino de 4 años de edad es traído a urgencias por presentar evacuaciones con sangre fresca (hematoquecia) en abundante cantidad, sin dolor abdominal ni fiebre. A la exploración física, el niño se encuentra pálido pero con abdomen blando y depresible, sin masas palpables.

Pregunta 1

¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva baja masiva e indolora en la edad pediátrica?

A) Intususcepción intestinal

B) Pólipos juveniles

C) Divertículo de Meckel *

D) Fisura anal

Retroalimentación:

El divertículo de Meckel es un remanente del conducto onfalomesentérico. La causa del sangrado es la presencia de mucosa gástrica ectópica dentro del divertículo, la cual produce ácido y ulcera la mucosa ileal adyacente. Se conoce como la "regla de los 2": afecta al 2% de la población, está a 2 pies de la válvula ileocecal y mide 2 pulgadas.

Pregunta 2

¿Cuál es el estudio diagnóstico inicial de elección para detectar el divertículo de Meckel cuando existe sospecha por sangrado?

A) Colonoscopia

B) Gammagrafía con Tecnecio-99m (Gammagrama de Meckel) *

C) Serie esofagogastroduodenal

D) Laparotomía exploradora inmediata

Retroalimentación:

El gammagrama con pertecnetato de Tecnecio-99m tiene afinidad por las células muco-secretoras gástricas, por lo que "ilumina" la mucosa ectópica del divertículo. Es la prueba diagnóstica de elección en niños con sangrado rectal indoloro.

Tema: ATLS / TRAUMA DE EXTREMIDADES

Subtema: SÍNDROME COMPARTIMENTAL

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Masculino de 30 años ingresa tras sufrir una fractura cerrada de tibia y peroné derecha por aplastamiento. Tras la colocación de una férula de yeso, el paciente refiere un dolor desproporcionado a la lesión, que no cede con opioides y que aumenta notablemente al realizar la extensión pasiva de los dedos del pie. El pulso pedio está presente pero débil.

Pregunta 1

¿Cuál es el signo o síntoma clínico más temprano y sensible para el diagnóstico del síndrome compartimental?

A) Ausencia de pulsos distales (Pulselessness)

B) Palidez de la extremidad (Pallor)

C) Dolor desproporcionado al estiramiento pasivo (Pain) *

D) Parálisis muscular (Paralysis)

Retroalimentación:

El dolor desproporcionado a los hallazgos físicos y el dolor al estiramiento pasivo son los signos más tempranos. Los pulsos suelen mantenerse presentes hasta etapas muy tardías, por lo que su presencia NO descarta el diagnóstico. La presión intracompartimental por arriba de 30 mmHg confirma la sospecha.

Pregunta 2

¿Cuál es el tratamiento de urgencia definitivo para salvar la extremidad y evitar la necrosis muscular (contractura isquémica de Volkmann)?

A) Retiro del yeso y elevación de la extremidad

B) Fasciotomía de los compartimentos afectados *

C) Administración de manitol intravenoso

D) Amputación infracondílea

Retroalimentación:

La fasciotomía descompresiva inmediata es el único tratamiento efectivo. En la pierna, se deben liberar los cuatro compartimentos (anterior, lateral, posterior superficial y posterior profundo) para restaurar la perfusión tisular.

Tema: UROLOGÍA QUIRÚRGICA

Subtema: TORSIÓN TESTICULAR

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Masculino de 14 años despierta súbitamente con dolor escrotal izquierdo intenso, náuseas y vómito. A la exploración: el testículo izquierdo está ascendido, con eje horizontalizado. El reflejo cremastérico está ausente y el dolor NO mejora al elevar el testículo (Signo de Prehn negativo).

Pregunta 1

Ante la sospecha de torsión testicular, ¿cuál es el tiempo de ventana (en horas) desde el inicio de los síntomas para realizar la detorsión quirúrgica y asegurar la viabilidad del testículo en el 90% de los casos?

A) Menos de 6 horas *

B) 12 a 24 horas

C) 48 horas

D) No hay límite de tiempo

Retroalimentación:

La torsión testicular es una urgencia quirúrgica absoluta. Si se opera antes de las 6 horas, la tasa de salvamento es >90%. Después de las 12-24 horas, la probabilidad de infarto testicular y necesidad de orquiectomía es casi total. El signo de Prehn negativo y la ausencia del reflejo cremastérico lo diferencian de la epididimitis (donde el dolor sí mejora al elevar el escroto).

Tema: GASTROENTEROLOGÍA QUIRÚRGICA

Subtema: VÓLVULO DE CIEGO

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Femenina de 45 años, sin antecedentes de importancia, acude por dolor abdominal agudo, náuseas y vómitos. A la exploración física se observa gran distensión abdominal localizada principalmente en el epigastrio e hipocondrio izquierdo. La radiografía simple de abdomen muestra una gran asa intestinal dilatada en forma de "embudo" o "gota de agua" cuyo vértice apunta hacia el cuadrante inferior derecho.

Pregunta 1

A diferencia del vólvulo de sigmoides, el vólvulo de ciego es menos frecuente y suele presentarse en pacientes más jóvenes. ¿Cuál es la causa anatómica más común que predispone a esta patología?

A) Malrotación intestinal persistente

B) Fijación inadecuada del ciego al peritoneo posterior (ciego móvil) *

C) Presencia de bridas postoperatorias

D) Dieta excesiva en fibra

Retroalimentación:

El vólvulo de ciego ocurre cuando este y el colon ascendente no están fijados al retroperitoneo, permitiendo que roten sobre su mesenterio. A diferencia del sigmoides (donde el asa apunta a la pelvis), en el vólvulo de ciego el asa suele desplazarse hacia el hipocondrio izquierdo.

Pregunta 2

Si durante la cirugía se confirma que el ciego está viable (no hay necrosis ni perforación), ¿cuál es el procedimiento quirúrgico de fijación recomendado para prevenir la recurrencia?

A) Hemicolectomía derecha con ileotransverso anastomosis

B) Cecopexia *

C) Procedimiento de Hartmann

D) Apendicectomía profiláctica únicamente

Retroalimentación:

En casos de ciego viable, la cecopexia (fijar el ciego al peritoneo parietal) es una opción. Sin embargo, si existe compromiso vascular o gangrena, la hemicolectomía derecha es el procedimiento de elección.

Tema: ATLS / TRAUMA DE TÓRAX

Subtema: TAPONAMIENTO CARDÍACO

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Masculino de 28 años ingresa tras herida por arma blanca en el área precordial. El paciente está consciente pero muy ansioso. Signos vitales: TA 80/50 mmHg, FC 130 lpm. A la exploración se observa ingurgitación yugular y los ruidos cardíacos se escuchan muy distantes o apagados.

Pregunta 1

La combinación de hipotensión, ruidos cardíacos velados y distensión de las venas del cuello es un hallazgo clásico en el trauma precordial. ¿Qué nombre recibe esta tríada clínica?

A) Tríada de Rigler

B) Tríada de Beck *

C) Tríada de Virchow

D) Tríada de Cushing

Retroalimentación:

La Tríada de Beck es el sello clínico del taponamiento cardíaco. La acumulación de sangre en el saco pericárdico impide el llenado ventricular, lo que genera caída del gasto cardíaco (hipotensión) y congestión venosa sistémica (ingurgitación yugular).

Pregunta 2

¿Cuál es el estudio de elección (rápido y no invasivo) que confirma la presencia de líquido en el espacio pericárdico en el área de choque?

A) Radiografía de tórax (signo del garrafón)

B) Ventana pericárdica quirúrgica

C) Ecografía enfocada en trauma (FAST) *

D) Electrocardiograma de 12 derivaciones

Retroalimentación:

El ultrasonido FAST es la herramienta diagnóstica de elección. Permite visualizar el derrame pericárdico de forma inmediata. Si el paciente está en paro o extrema inestabilidad, el tratamiento es la pericardiocentesis de urgencia o una toracotomía de reanimación.

Tema: UROLOGÍA (ONCOLOGÍA)

Subtema: CÁNCER DE TESTÍCULO

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Masculino de 24 años acude por notar un aumento de tamaño y pesadez en el testículo derecho de 2 meses de evolución. No refiere dolor ni traumatismos. A la exploración se palpa una masa intratesticular pétrea, firme e indolora que no transilumina.

Pregunta 1

Ante la sospecha de cáncer de testículo en un paciente joven, ¿cuál es el abordaje quirúrgico inicial indicado para el diagnóstico y tratamiento primario?

A) Biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF)

B) Orquiectomía radical por vía inguinal *

C) Orquiectomía simple por vía escrotal

D) Biopsia incisional del tumor

Retroalimentación:

El cáncer de testículo NUNCA se debe biopsiar ni abordar por vía escrotal debido al riesgo de diseminación linfática hacia los ganglios inguinales (que no es su drenaje natural). El abordaje siempre debe ser inguinal con ligadura temprana del cordón espermático.

Pregunta 2

¿Cuáles son los marcadores tumorales séricos que deben solicitarse para la estadificación y seguimiento de los tumores germinales de testículo?

A) ACE y CA 19-9

B) Alfafetoproteína (AFP) y Fracción beta de la hGC *

C) Antígeno Prostático Específico (APE)

D) CA-125 y Calcitonina

Retroalimentación:

La AFP y la hGC-beta son fundamentales. La AFP nunca se eleva en los seminomas puros; por lo tanto, si un seminoma tiene AFP elevada, debe tratarse como un tumor no seminomatoso (más agresivo).

Tema: CIRUGÍA VASCULAR

Subtema: INSUFICIENCIA ARTERIAL AGUDA

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Femenina de 72 años, con antecedente de fibrilación auricular sin tratamiento anticoagulante, acude por dolor súbito e intenso en la pierna izquierda de 2 horas de evolución. A la exploración, la extremidad está fría, pálida y no se palpan pulsos pedio ni tibial posterior. Presenta disminución de la sensibilidad en los dedos.

Pregunta 1

Este cuadro clínico se resume frecuentemente con la regla de las "6 P" de la isquemia arterial aguda. ¿Cuál de las siguientes "P" indica un daño avanzado y mal pronóstico para la viabilidad de la extremidad?

A) Pain (Dolor)

B) Pallor (Palidez)

C) Paresthesia / Paralysis (Parestesia o Parálisis) *

D) Pulselessness (Ausencia de pulso)

Retroalimentación:

Mientras que el dolor y la palidez son iniciales, la aparición de pérdida de la sensibilidad (parestesia) y motilidad (parálisis) indica isquemia muscular y nerviosa crítica. Es una emergencia que requiere embolectomía con sonda de Fogarty o trombólisis inmediata para evitar la amputación.

Tema: GASTROENTEROLOGÍA QUIRÚRGICA

Subtema: ENFERMEDAD POR REFLUJO GASTROESOFÁGICO (TRATAMIENTO QUIRÚRGICO)

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Femenina de 42 años con diagnóstico de ERGE de 5 años de evolución. Ha sido tratada con IBP a dosis máximas con alivio parcial de los síntomas. La paciente no desea continuar con tratamiento farmacológico de por vida. La pH-metría de 24 horas reporta un Score de DeMeester de 24 (normal <14.7) y la manometría muestra un esfínter esofágico inferior con presión de 6 mmHg (hipotenso). La endoscopia revela una hernia hiatal por deslizamiento de 3 cm.

Pregunta 1

De acuerdo con las indicaciones de la GPC, ¿cuál es el procedimiento quirúrgico de elección (estándar de oro) para esta paciente con ERGE refractario y presencia de hernia hiatal?

A) Funduplicatura parcial tipo Toupet (270°)

B) Funduplicatura total tipo Nissen (360°) *

C) Cardiomiotomía de Heller

D) Bypass gástrico en Y de Roux

Retroalimentación:

La funduplicatura total tipo Nissen laparoscópica es el tratamiento quirúrgico de elección para el ERGE. Consiste en rodear completamente el esófago distal con el fundus gástrico para crear una nueva zona de alta presión. Se indica en pacientes con respuesta parcial a IBP, deseo de suspender fármacos o complicaciones como esofagitis persistente.

Tema: ATLS / TRAUMA ABDOMINAL

Subtema: TRAUMA RENAL

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Masculino de 19 años sufre traumatismo contuso en flanco derecho durante un partido de fútbol americano. Presenta dolor intenso y hematuria macroscópica franca. Sus signos vitales son estables (TA 115/75, FC 88 lpm). Se solicita una TAC de abdomen con contraste en fase excretora que muestra una laceración cortical profunda que se extiende hasta el sistema colector (cálices), con extravasación de contraste, pero sin lesión de la arteria renal principal.

Pregunta 1

De acuerdo con la clasificación de la AAST (American Association for the Surgery of Trauma), ¿qué grado de lesión renal presenta este paciente al existir compromiso del sistema colector?

A) Grado II

B) Grado III

C) Grado IV *

D) Grado V

Retroalimentación:

Las lesiones renales grado IV incluyen laceraciones que se extienden a través de la corteza, médula y sistema colector (con extravasación de orina/contraste) o lesiones de la arteria o vena renal con hemorragia contenida. El grado III es una laceración de más de 1 cm pero SIN lesión del sistema colector.

Pregunta 2

Dado que el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, ¿cuál es el manejo inicial de elección para esta lesión grado IV?

A) Nefrectomía total de urgencia

B) Manejo conservador (reposo absoluto, antibióticos y vigilancia estrecha) *

C) Colocación inmediata de un stent doble J

D) Exploración quirúrgica para reparación de la laceración

Retroalimentación:

En la actualidad, la tendencia en trauma renal es el manejo conservador en pacientes estables, incluso en grados IV. La mayoría de las fugas urinarias cierran espontáneamente. La cirugía (nefrectomía o reparación) se reserva exclusivamente para inestabilidad hemodinámica persistente o avulsión del hilio renal (Grado V).

Tema: UROLOGÍA (ONCOLOGÍA)

Subtema: CÁNCER DE VEJIGA

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Masculino de 65 años, fumador de 40 paquetes/año, acude por presentar tres episodios de hematuria macroscópica total, formadora de coágulos, sin dolor asociado. Refiere que la orina vuelve a ser clara espontáneamente. No tiene síntomas obstructivos.

Pregunta 1

Ante un paciente mayor con tabaquismo crónico y hematuria macroscópica indolora, se debe sospechar cáncer de vejiga (carcinoma de células transicionales). ¿Cuál es el estudio inicial más importante para visualizar la lesión y realizar una toma de biopsia?

A) Citología urinaria en tres muestras

B) Urotomografía (UroTAC)

C) Cistoscopia con toma de biopsia *

D) Antígeno prostático específico

Retroalimentación:

La cistoscopia es fundamental para el diagnóstico, permitiendo ver la masa (generalmente papilar) y tomar muestras. El tabaquismo es el factor de riesgo más importante para este cáncer. El estudio de extensión para ver el tracto urinario superior se realiza con UroTAC.

Pregunta 2

Si el reporte de patología indica un tumor que invade la capa muscular propia (Tumor Musculoinvasor - T2), ¿cuál es el tratamiento estándar con intención curativa?

A) Resección Transuretral de Vejiga (RTUV) únicamente

B) Cistectomía radical con derivación urinaria *

C) Quimioterapia intravesical con BCG

D) Vigilancia activa con cistoscopias cada 3 meses

Retroalimentación:

Para tumores no invasores de músculo (Ta, T1), la RTUV más quimioterapia/inmunoterapia intravesical (BCG) es suficiente. Sin embargo, una vez que el tumor invade el músculo (T2 o más), se requiere una cirugía mayor: la cistectomía radical.

Tema: ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

Subtema: FRACTURA DE COLLES

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Femenina de 68 años cae sobre la palma de su mano derecha en extensión. Presenta dolor intenso en la muñeca y una deformidad característica con desplazamiento dorsal del fragmento distal del radio, que se asemeja a un "tenedor".

Pregunta 1

¿Cómo se denomina clásicamente a esta fractura del radio distal con desplazamiento dorsal?

A) Fractura de Smith

B) Fractura de Colles *

C) Fractura de Barton

D) Fractura de Hutchinson (del Chauffeur)

Retroalimentación:

La fractura de Colles es la fractura del radio distal más común, caracterizada por desplazamiento dorsal (deformidad en "dorso de tenedor"). La fractura de Smith es lo opuesto: caída sobre el dorso de la mano con desplazamiento ventral ("deformidad en pala de jardinero").

Tema: ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR

Subtema: INSUFICIENCIA VENOSA CRÓNICA (IVC)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Medio):

Femenina de 48 años, de ocupación cajera de supermercado (permanece 8 horas de pie), con antecedente de 3 embarazos. Acude por presentar pesadez y dolor en ambas piernas que aumenta al final del día, así como edema que disminuye con el reposo nocturno. A la exploración física se observan venas dilatadas y tortuosas en trayecto de la safena interna, además de hiperpigmentación ocre en la región maleolar de ambos tobillos.

Pregunta 1

De acuerdo con la clasificación clínica de CEAP para los trastornos venosos crónicos, ¿en qué estadio se encuentra una paciente que ya presenta cambios cutáneos como la hiperpigmentación ocre (lipodermatoesclerosis)?

A) C2 (Venas varicosas)

B) C3 (Edema)

C) C4 *

D) C6 (Úlcera activa)

Retroalimentación:

La clasificación CEAP es fundamental: C1 (telangiectasias), C2 (várices), C3 (edema), C4 (cambios cutáneos: pigmentación, eccema), C5 (úlcera cicatrizada) y C6 (úlcera activa). El manejo inicial siempre es conservador con medidas de higiene venosa y medias de compresión graduada.

Tema: CIRUGÍA DE PARED ABDOMINAL

Subtema: HERNIA DE SPIEGEL

Dificultad: Alta

Caso clínico (Corto):

Masculino de 60 años acude por dolor localizado en el borde lateral del músculo recto abdominal, a nivel de la línea semicircular (de Douglas). A la exploración se palpa una pequeña masa profunda que se hace más evidente al contraer la musculatura abdominal.

Pregunta 1

¿Cuál es la localización anatómica característica donde se produce la Hernia de Spiegel?

A) A través de la línea alba

B) En la línea semilunar, entre el recto abdominal y los músculos laterales *

C) A través del conducto obturador

D) En el triángulo de Petit (lumbar inferior)

Retroalimentación:

La hernia de Spiegel es una hernia intersticial que ocurre a través de la aponeurosis de Spiegel, situada entre la línea semilunar (borde lateral del recto) y el músculo oblicuo externo. Debido a que el defecto suele ser pequeño y cubierto por la aponeurosis del oblicuo externo, tiene un alto riesgo de encarcelamiento.

Tema: ATLS / TRAUMA DE TÓRAX

Subtema: TÓRAX INESTABLE (VOLET COSTAL)

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Masculino de 35 años ingresa tras accidente automovilístico con impacto frontal. Presenta dolor torácico severo y dificultad respiratoria. A la inspección, se observa que un segmento de la pared costal anterior derecha se hunde durante la inspiración y protruye durante la expiración.

Pregunta 1

¿Cuál es la definición diagnóstica de tórax inestable según el ATLS?

A) Fractura de una sola costilla en dos o más partes

B) Fractura de dos o más costillas consecutivas en dos o más partes *

C) Fractura del esternón asociada a una costilla

D) Fractura de todas las costillas de un hemitórax

Retroalimentación:

El tórax inestable se define por la fractura de 2 o más costillas adyacentes en 2 o más partes, lo que crea un segmento óseo desarticulado que presenta un movimiento paradójico (inverso al resto del tórax). La principal complicación no es la fractura en sí, sino la contusión pulmonar subyacente que causa hipoxemia.

Tema: UROLOGÍA

Subtema: PRIAPISMO

Dificultad: Alta

Caso clínico (Corto):

Masculino de 28 años, con antecedente de anemia de células falciformes (drepanocitosis), acude por presentar erección dolorosa de 6 horas de evolución, no asociada a estímulo sexual. A la exploración, los cuerpos cavernosos están rígidos, pero el glande y el cuerpo esponjoso están blandos.

Pregunta 1

¿Cuál es el tipo de priapismo más frecuente (isquémico o no isquémico) y cuál es el tratamiento inicial de elección tras el fracaso de la aspiración simple?

A) No isquémico (alto flujo); observación

B) Isquémico (bajo flujo); inyección intracavernosa de fenilefrina *

C) Isquémico; administración de sildenafilo

D) No isquémico; cirugía de shunt inmediata

Retroalimentación:

El priapismo isquémico (de bajo flujo) es una urgencia verdadera por riesgo de fibrosis y disfunción eréctil permanente. Es común en pacientes con drepanocitosis. El

tratamiento consiste en la aspiración de la sangre estancada (oscura) e inyección de agentes simpaticomiméticos (como fenilefrina) para causar vasoconstricción y detumescencia.

Tema: CIRUGÍA DE PARED ABDOMINAL

Subtema: HERNIAS RARAS (AMYAND Y GARENGEOT)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Corto):

Masculino de 65 años acude por dolor intenso en la región inguinal derecha y presencia de una masa no reductible. A la exploración quirúrgica de urgencia por sospecha de hernia inguinal encarcelada, se encuentra que el contenido del saco herniario es el apéndice cecal con datos de inflamación aguda (apendicitis).

Pregunta 1

¿Qué nombre recibe el hallazgo de un apéndice cecal (inflamado o no) dentro de un saco de hernia inguinal?

A) Hernia de Richter

B) Hernia de Amyand *

C) Hernia de Garengeot

D) Hernia de Littré

Retroalimentación:

La hernia de Amyand es la presencia del apéndice dentro de un saco de hernia inguinal. Si el apéndice se encuentra dentro de un saco de hernia crural (femoral), se denomina hernia de Garengeot. La de Littré contiene un divertículo de Meckel y la de Richter solo una parte de la pared antimesentérica del intestino.

Tema: ATLS / TRAUMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO

Subtema: FRACTURA DE PELVIS

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Masculino de 28 años, atropellado por vehículo pesado. Ingresa con inestabilidad hemodinámica grave (TA 70/40 mmHg, FC 140 lpm). A la exploración se observa equimosis perineal y sangrado por el meato urinario. Al realizar la maniobra de compresión-distracción de las crestas ilíacas, se percibe inestabilidad mecánica de la pelvis.

Pregunta 1

Ante un paciente con fractura de pelvis inestable y choque hemorrágico, ¿cuál es la medida inicial de urgencia para reducir el volumen pélvico y controlar el sangrado venoso antes de pasar a una intervención definitiva?

A) Fijación interna con placas y tornillos

B) Colocación de una sábana o cinturón pélvico a nivel de los trocánteres mayores *

C) Laparotomía exploradora inmediata

D) Arteriografía con embolización

Retroalimentación:

El cierre del anillo pélvico mediante un cinturón o sábana reduce el espacio muerto y genera un efecto de taponamiento sobre el plexo venoso presacro, que es la fuente del 90% de los sangrados en fracturas de pelvis. Debe colocarse a la altura de los trocánteres mayores para ser efectivo.

Tema: UROLOGÍA (ONCOLOGÍA)

Subtema: CÁNCER DE PENE

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Masculino de 60 años, con antecedente de tabaquismo y fimosis crónica (nunca se ha realizado circuncisión). Acude por presentar una lesión ulcerada, indolora, de bordes irregulares en el glande, que ha crecido en los últimos 4 meses y presenta secreción fétida.

Pregunta 1

¿Cuál es el tipo histológico más común del cáncer de pene y cuál es el principal factor de riesgo prevenible asociado?

A) Adenocarcinoma; Infección por Hepatitis B

B) Carcinoma epidermoide (células escamosas); Infección por VPH y falta de circuncisión *

C) Sarcoma de partes blandas; Traumatismos repetidos

D) Carcinoma de células claras; Diabetes Mellitus

Retroalimentación:

El carcinoma epidermoide representa más del 95% de los casos. La falta de circuncisión favorece la acumulación de esmegma e inflamación crónica (balanitis), lo que sumado a la infección por Virus del Papiloma Humano (VPH 16 y 18) son los principales detonantes.

Tema: NUTRICIÓN Y CIRUGÍA

Subtema: VALORACIÓN NUTRICIONAL PREOPERATORIA

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Paciente de 70 años programado para una cirugía mayor oncológica. El cirujano desea evaluar el riesgo de complicaciones postoperatorias relacionadas con el estado nutricional.

Pregunta 1

De los siguientes parámetros de laboratorio, ¿cuál ha demostrado tener el mayor valor pronóstico para predecir morbi-mortalidad y dehiscencia de suturas en el paciente quirúrgico?

A) Hemoglobina glucosilada

B) Albúmina sérica *

C) Colesterol total

D) Creatinina en orina de 24 horas

Retroalimentación:

La albúmina sérica (menor a 3.0 - 3.5 g/dl) es el marcador bioquímico más utilizado y con mayor evidencia para predecir complicaciones postquirúrgicas, estancias hospitalarias prolongadas y mortalidad en cirugía mayor. Indica desnutrición proteica crónica.

Tema: CIRUGÍA GENERAL

Subtema: TRATAMIENTO DE LA QUELOIDE

Dificultad: Media

Pregunta 1

¿Cuál es el tratamiento médico de primera línea para reducir el tamaño y los síntomas (dolor/prurito) de una cicatriz queloide?

A) Antibióticos tópicos

B) Inyección intralesional de corticoesteroides (Triamcinolona) *

C) Resección quirúrgica simple únicamente

D) Aplicación de radioterapia externa como monoterapia

Retroalimentación:

La infiltración intralesional con corticoesteroides es el tratamiento de elección para queloides, ya que disminuye la síntesis de colágeno y la inflamación. La cirugía sola tiene una tasa de recurrencia de hasta el 80%, por lo que si se opera, debe combinarse con esteroides o presoterapia.

Tema: GINECOLOGÍA Y CIRUGÍA DE MAMA

Subtema: FIBROADENOMA MAMARIO

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Femenina de 22 años acude por notar un "bultito" en la mama izquierda desde hace 2 meses. No refiere dolor ni cambios con el ciclo menstrual. A la exploración física se palpa un nódulo de 2 cm, de consistencia firme (gomosa), bordes regulares, muy móvil y no adherido a planos profundos. No se palpan adenopatías axilares.

Pregunta 1

Dada la edad de la paciente y las características clínicas del nódulo (móvil, firme, bien delimitado), ¿cuál es el diagnóstico benigno más probable?

A) Quiste mamario simple

B) Fibroadenoma *

C) Condición fibroquística

D) Papiloma intraductal

Retroalimentación:

El fibroadenoma es el tumor benigno más frecuente de la mama en mujeres jóvenes (menores de 30 años). Su característica clínica clave es la gran movilidad ("ratón mamario"). A diferencia de los quistes, su consistencia es sólida y gomosa.

Tema: ATLS / TRAUMA UROLÓGICO

Subtema: LESIÓN DE URETRA

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Masculino de 35 años sufre accidente por caída a horcajadas sobre una barra de metal. Acude por dolor perineal intenso y presencia de sangre en el meato urinario (uretrorragia). El paciente refiere deseos de orinar pero no puede hacerlo. A la exploración se observa un hematoma en "alas de mariposa" en el periné y el escroto.

Pregunta 1

Ante la presencia de uretrorragia e imposibilidad para la micción tras un trauma perineal, ¿cuál es el estudio de imagen inicial que debe realizarse para confirmar una ruptura de uretra antes de intentar colocar una sonda Foley?

A) Cistoscopia de urgencia

B) Uretrografía retrógrada *

C) Tomografía axial computarizada

D) Ultrasonido suprapúbico

Retroalimentación:

La uretrografía retrógrada (inyección de contraste a través del meato) es el estándar de oro para diagnosticar lesiones uretrales. Si hay sospecha de lesión de uretra (uretrorragia, hematoma perineal o próstata flotante), la colocación de una sonda Foley está contraindicada hasta descartar la ruptura, ya que podría convertir una lesión parcial en una completa.

Tema: UROLOGÍA (ONCOLOGÍA)

Subtema: CÁNCER DE PRÓSTATA (BIOPSIA)

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Masculino de 62 años acude a revisión prostática. El Antígeno Prostático Específico (APE) se reporta en 7.2 ng/ml. Al realizar el tacto rectal, se palpa un nódulo de consistencia pétrea en el lóbulo derecho.

Pregunta 1

De acuerdo con las guías de práctica clínica, ¿cuál es la conducta a seguir tras encontrar un tacto rectal sospechoso y un APE elevado?

A) Repetir el APE en 3 meses

B) Realizar biopsia transrectal de próstata guiada por ultrasonido *

C) Iniciar tratamiento con tamsulosina

D) Realizar una gammagrafía ósea directamente

Retroalimentación:

Cualquier hallazgo sospechoso al tacto rectal (nódulos, induración) o un APE persistentemente elevado son indicaciones para biopsia. La biopsia transrectal es el método estándar para confirmar el adenocarcinoma de próstata y determinar el grado de Gleason.

Tema: GASTROENTEROLOGÍA QUIRÚRGICA

Subtema: ENFERMEDAD DE CROHN (COMPLICACIONES)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Corto):

Femenina de 28 años con diagnóstico de Enfermedad de Crohn de 5 años de evolución. Acude por dolor abdominal, distensión y vómitos. La TC de abdomen muestra un segmento de íleon terminal con engrosamiento de la pared ("signo de la cuerda") y una fístula que comunica el intestino con la vejiga (fístula enterovesical).

Pregunta 1

¿Cuál es la indicación quirúrgica más común en pacientes con Enfermedad de Crohn que no responden al tratamiento médico?

A) Prevención de cáncer colorrectal

B) Tratamiento de fístulas o estenosis sintomáticas *

C) Colectomía total profiláctica

D) Apendicectomía incidental

Retroalimentación:

A diferencia del CUCI (donde la cirugía es curativa), en el Crohn la cirugía no cura la enfermedad y es recurrente. Por lo tanto, se opera solo para tratar complicaciones como obstrucciones (por estenosis), fístulas sintomáticas o abscesos que no drenan por vía percutánea.

Tema: CIRUGÍA GENERAL

Subtema: LÍQUIDOS Y ELECTROLITOS (HIPOPOTASEMIA POSTQUIRÚRGICA)

Dificultad: Media

Pregunta 1

Un paciente postoperado de resección intestinal presenta íleo paralítico prolongado. En sus laboratorios se detecta un potasio sérico de 2.8 mEq/L. ¿Cuál es la alteración

electrocardiográfica característica que esperaría encontrar asociada a esta hipopotasemia?

A) Ondas T picudas y simétricas

B) Acortamiento del intervalo QT

C) Presencia de ondas U y aplanamiento de la onda T *

D) Ensanchamiento del complejo QRS

Retroalimentación:

La hipopotasemia es una causa frecuente de íleo postoperatorio. Sus signos en el EKG incluyen aplanamiento o inversión de la onda T, depresión del segmento ST y la aparición de la onda U (una deflexión después de la T).

Tema: PROCTOLOGÍA

Subtema: HEMORROIDES

Dificultad: Baja

Caso clínico (Medio):

Masculino de 45 años, con antecedente de estreñimiento crónico, acude por presentar protuberancias en la región anal tras la defecación. Refiere que estas masas "salen" al pujar y debe reintroducirlas manualmente para aliviar la molestia. Presenta sangrado rojo rutilante ocasional al limpiar con papel higiénico. No hay dolor intenso.

Pregunta 1

De acuerdo con la clasificación interna de las hemorroides por grados, ¿en qué grado se clasifica a un paciente cuyas hemorroides prolapsan pero requieren reducción manual?

A) Grado I

B) Grado II

C) Grado III *

D) Grado IV

Retroalimentación:

Grado I: No prolapsan. Grado II: Prolapsan al evacuar pero reducen espontáneamente. Grado III: Prolapsan y requieren reducción manual. Grado IV: Prolapso persistente que no se puede reducir. El tratamiento inicial es fibra y líquidos; para Grado III/IV el estándar de oro quirúrgico es la Hemorroidectomía (técnica de Ferguson o Milligan-Morgan).

Tema: ATLS / TRAUMA DE TÓRAX

Subtema: HEMOTÓRAX MASIVO

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Masculino de 30 años ingresa tras herida por proyectil de arma de fuego en hemitórax izquierdo. El paciente está hipotenso (TA 80/40), taquicárdico y con dificultad respiratoria. A la exploración: ausencia de ruidos respiratorios en el lado izquierdo y matidez a la percusión del mismo lado. Se coloca un tubo de tórax (pleurostomía) obteniéndose de forma inmediata 1,600 ml de sangre fresca.

Pregunta 1

De acuerdo con los criterios del ATLS, ¿cuál es la indicación absoluta de realizar una toracotomía de urgencia en quirófano en este paciente?

A) Salida inicial de >1,500 ml de sangre o gasto persistente de >200 ml/hr por 2-4 horas *

B) Presencia de cualquier cantidad de sangre en el espacio pleural

C) Necesidad de transfundir 2 paquetes globulares

D) Hemotórax menor a 1,000 ml que se estabiliza con cristaloides

Retroalimentación:

El hemotórax masivo se define por la acumulación rápida de >1,500 ml de sangre. Es una indicación de cirugía inmediata para localizar la fuente del sangrado (generalmente arterias intercostales o mamaria interna). Si el drenaje inicial es menor pero continúa sangrando a un ritmo de 200 ml/hr, también se debe operar.

Tema: UROLOGÍA (INFECTOLOGÍA)

Subtema: ORQUIEPIDIDIMITIS

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Masculino de 22 años acude por dolor escrotal derecho de inicio gradual (2 días), acompañado de disuria y fiebre de 38.5°C. A la exploración: el epidídimo está indurado y doloroso. El reflejo cremastérico está presente. El dolor disminuye significativamente cuando el médico eleva el escroto hacia la sínfisis del pubis.

Pregunta 1

La mejoría del dolor al elevar el testículo afectado es un signo clínico que ayuda a diferenciar la epididimitis de la torsión testicular. ¿Qué nombre recibe este signo?

A) Signo de Prehn positivo *

B) Signo de Gouverneur

C) Signo de Kehr

D) Signo de Murphy

Retroalimentación:

El Signo de Prehn positivo (alivio del dolor al elevar el testículo) sugiere orquiepididimitis. En la torsión testicular, el signo es negativo (el dolor no mejora o

empeora). En hombres menores de 35 años, los agentes causales más comunes son Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae.

Tema: ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

Subtema: FRACTURA DE TOBILLO (WEBER)

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Femenina de 30 años sufre eversión forzada del tobillo derecho mientras practicaba deporte. Presenta dolor intenso, edema y deformidad. La radiografía muestra una fractura del peroné que se localiza por encima del nivel de la sindesmosis tibioperonea.

Pregunta 1

Utilizando la clasificación de Danis-Weber para fracturas de tobillo, ¿cómo se clasifica una fractura del peroné que ocurre por arriba de la sindesmosis y que generalmente implica una lesión de la misma?

A) Weber A

B) Weber B

C) Weber C *

D) Weber D

Retroalimentación:

Weber A: Infrasindesmal (estable). Weber B: Transindesmal (parcialmente estable). Weber C: Suprasindesmal (inestable, requiere casi siempre reducción abierta y fijación interna).

Tema: CIRUGÍA GENERAL

Subtema: GAS EN LA VÍA BILIAR (AEROBILIA)

Dificultad: Media

Pregunta 1

En un paciente con cuadro de obstrucción intestinal, la presencia de aire en la vía biliar (aerobilia) en una radiografía de abdomen sugiere fuertemente la existencia de:

A) Colecistitis aguda litiásica simple

B) Fístula colecistoentérica (Íleo biliar) *

C) Coledocolitiasis obstructiva

D) Quiste de colédoco

Retroalimentación:

La aerobilia es un signo clave del íleo biliar. El lito erosiona la pared de la vesícula y crea una fístula hacia el duodeno, permitiendo que el aire del intestino suba a la vía biliar y que el lito baje hasta impactarse (usualmente en la válvula ileocecal).

Tema: UROLOGÍA

Subtema: LITIASIS VESICAL

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Masculino de 68 años con antecedente de crecimiento prostático obstructivo. Acude por presentar dolor suprapúbico, hematuria terminal y una característica interrupción brusca del chorro urinario que se reanuda al cambiar de posición.

Pregunta 1

¿Cuál es la causa fisiopatológica más común de la formación de litos vesicales en pacientes masculinos de edad avanzada?

A) Hipercalciuria idiopática

B) Estasis urinaria por obstrucción del flujo de salida (HPB) *

C) Infecciones por Proteus mirabilis

D) Deficiencia de citrato en la dieta

Retroalimentación:

En adultos, la mayoría de los litos vesicales se forman de manera secundaria a la estasis urinaria provocada por una obstrucción (como la Hiperplasia Prostática Benigna). El cambio de posición permite que el lito se mueva del cuello vesical, permitiendo que el chorro continúe.

Tema: ATLS / TRAUMA DE TÓRAX

Subtema: CONTUSIÓN PULMONAR

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Masculino de 25 años tras accidente en motocicleta con impacto directo en el pecho. Inicialmente presenta estabilidad hemodinámica, pero 6 horas después desarrolla taquipnea, aumento del trabajo respiratorio e hipoxemia (PaO_2 <60 mmHg). La radiografía de tórax inicial era normal, pero la actual muestra infiltrados alveolares irregulares no segmentarios en el pulmón derecho.

Pregunta 1

¿Cuál es el hallazgo característico en la tomografía computarizada (TAC) que confirma el diagnóstico de contusión pulmonar y la diferencia de una neumonía aspirativa?

A) Áreas de consolidación en parches (vidrio despulido) que no respetan los límites lobares *

B) Presencia de aire en el espacio pleural

C) Desviación del mediastino hacia el lado contralateral

D) Engrosamiento de las líneas de Kerley B

Retroalimentación:

La contusión pulmonar es la lesión torácica potencialmente letal más común. Se caracteriza por hemorragia alveolar y edema. Típicamente, los infiltrados aparecen horas después del trauma y no respetan la anatomía lobar, a diferencia de la neumonía. El tratamiento es soporte ventilatorio y restricción juiciosa de líquidos.

Tema: QUEMADURAS

Subtema: CRITERIOS DE ENVÍO A UNIDAD DE QUEMADOS

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Masculino de 20 años que sufre quemaduras por contacto con aceite hirviendo en ambas manos (palma y dorso) y genitales. Las lesiones son de segundo grado profundo.

Pregunta 1

De acuerdo con la ABA (American Burn Association), ¿cuál es el criterio por el cual este paciente debe ser referido obligatoriamente a una Unidad de Quemados Especializada?

A) Por ser quemaduras de segundo grado

B) Por el mecanismo de lesión (aceite)

C) Por afectar áreas especiales (manos y genitales) *

D) Por ser un paciente joven

Retroalimentación:

Los criterios de referencia incluyen: quemaduras de 2do grado >10% SCTQ, quemaduras en áreas especiales (cara, manos, pies, genitales, periné, articulaciones mayores), quemaduras de 3er grado, quemaduras eléctricas, químicas o por inhalación, y pacientes con comorbilidades complejas.

Tema: ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

Subtema: FRACTURA DE LA CÚPULA RADIAL (ESCALA DE MASON)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Corto):

Masculino de 32 años cae sobre la palma de la mano en extensión. Presenta dolor intenso en la cara lateral del codo y limitación para la pronosupinación. La radiografía muestra una fractura de la cabeza del radio con un desplazamiento del fragmento mayor a 2 mm que afecta más del 30% de la superficie articular.

Pregunta 1

De acuerdo con la clasificación de Mason para fracturas de la cúpula radial, ¿en qué grado se clasifica esta fractura desplazada y marginal?

A) Mason I

B) Mason II *

C) Mason III

D) Mason IV

Retroalimentación:

Mason I: No desplazada (tratamiento conservador). Mason II: Desplazada >2 mm o que afecta un sector de la cabeza (tratamiento quirúrgico usualmente). Mason III: Conminuta completa. Mason IV: Asociada a luxación de codo.

Tema: CIRUGÍA GENERAL

Subtema: ABSCESO HEPÁTICO PIÓGENO VS AMIBIANO

Dificultad: Media

Pregunta 1

¿Cuál es la vía de llegada más frecuente de las bacterias al hígado para la formación de un absceso hepático piógeno en la actualidad?

A) Vía portal (por apendicitis o diverticulitis)

B) Vía biliar (por colangitis o colecistitis) *

C) Extensión directa por contigüidad

D) Trauma penetrante

Retroalimentación:

Históricamente la vía portal era la más común (debido a apendicitis no tratadas), pero actualmente la patología de la vía biliar (ascendente) es la causa número uno de abscesos hepáticos piógenos. El germen más frecuentemente aislado es E. coli.

Tema: PROCTOLOGÍA

Subtema: FISURA ANAL

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Femenina de 32 años acude por dolor anal intenso "como si se cortara con un vidrio" que aparece durante la defecación y persiste varias horas después. Refiere miedo a evacuar por el dolor y presencia de escasa sangre roja brillante en el papel higiénico. A la exploración se observa una solución de continuidad lineal en el borde anal, localizada en la línea media posterior.

Pregunta 1

¿Cuál es el hallazgo característico que define a una fisura anal como "crónica" (más de 6 semanas de evolución)?

A) Presencia de pus y fiebre

B) Tríada de Brodie (papila anal hipertrófica, fisura y colgajo cutáneo o centinela) *

C) Localización de la fisura en la línea media anterior

D) Antecedente de hemorroides internas grado IV

Retroalimentación:

La fisura anal es un desgarro del anodermo. La cronicidad se identifica por la tríada de Brodie. El tratamiento inicial es conservador (fibra, baños de asiento y diltiazem tópico); si fracasa, el tratamiento quirúrgico de elección es la Esfinterotomía Lateral Interna (ELI).

Tema: ATLS / TRAUMA DE TÓRAX

Subtema: NEUMOTÓRAX SIMPLE

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Masculino de 22 años sufre herida por arma blanca en el 4to espacio intercostal derecho, línea axilar anterior. Se encuentra estable hemodinámicamente. A la

exploración: disminución de los ruidos respiratorios y timpanismo a la percusión en el hemitórax derecho. La tráquea está central y no hay ingurgitación yugular.

Pregunta 1

¿Cuál es el tratamiento definitivo indicado para este paciente con un neumotórax traumático abierto o simple que ocupa más del 20% del volumen del hemitórax?

A) Descompresión con aguja en el 2do espacio intercostal

B) Colocación de sonda endopleural (tubo de tórax) con sello de agua *

C) Toracotomía de urgencia

D) Observación y radiografías seriadas cada 6 horas

Retroalimentación:

A diferencia del neumotórax a tensión (que es una urgencia clínica), el neumotórax simple se confirma por radiografía y el tratamiento estándar es la colocación de un tubo de tórax para permitir la reexpansión pulmonar.

Tema: UROLOGÍA (ONCOLOGÍA)

Subtema: CARCINOMA DE CÉLULAS RENALES

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Masculino de 58 años, fumador, acude por presentar dolor sordo en el flanco izquierdo y un episodio de hematuria macroscópica. Al examen físico, se palpa una masa abdominal en el flanco izquierdo. El paciente también refiere haber notado un varicocele izquierdo de reciente aparición que no desaparece al acostarse.

Pregunta 1

La tríada clásica de cáncer renal (dolor, masa y hematuria) solo se presenta en el 10% de los casos. ¿Cuál es la causa fisiopatológica del varicocele izquierdo súbito en este paciente?

A) Metástasis directas al testículo

B) Obstrucción de la vena renal izquierda por un trombo tumoral, impidiendo el drenaje de la vena gonadal *

C) Invasión del tumor hacia el conducto deferente

D) Efecto secundario del tabaquismo crónico

Retroalimentación:

El cáncer de riñón (adenocarcinoma) tiene predilección por invadir la vena renal. Debido a que la vena gonadal izquierda drena directamente en la vena renal izquierda (a diferencia de la derecha que drena en la cava), un tumor renal izquierdo puede causar un varicocele secundario por obstrucción del flujo venoso. El tratamiento de elección para tumores localizados es la nefrectomía radical o parcial.

Tema: ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

Subtema: LUXACIÓN ANTERIOR DE HOMBRO

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Masculino de 21 años sufre caída sobre su brazo derecho en abducción y rotación externa mientras jugaba fútbol. Acude con dolor intenso y deformidad del hombro. A la exploración se observa pérdida del contorno redondeado del hombro (signo de la charretera) y el brazo se mantiene en ligera abducción.

Pregunta 1

¿Cuál es la dirección más frecuente de la luxación de hombro (glenohumeral) y qué lesión nerviosa se debe descartar obligatoriamente antes y después de la reducción?

A) Posterior; Nervio radial

B) Anterior; Nervio axilar (circunflejo) *

C) Inferior; Nervio cubital

D) Superior; Nervio mediano

Retroalimentación:

Más del 95% de las luxaciones de hombro son anteriores. El signo de la charretera es patognomónico. Es vital evaluar la sensibilidad en la región deltoidea para descartar lesión del nervio axilar. El tratamiento es la reducción cerrada mediante maniobras como la de Kocher o Milch, seguida de inmovilización.

Tema: CIRUGÍA GENERAL / ONCOLOGÍA

Subtema: TUMOR DE WARTHIN

Dificultad: Media

Pregunta 1

Masculino de 60 años, fumador pesado, presenta una tumoración de crecimiento lento, indolora y de consistencia elástica en la región parotídea derecha. Se realiza una gammagrafía con Tecnecio-99m que muestra una zona de hipercaptación ("nódulo caliente"). ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Adenoma pleomorfo

B) Carcinoma mucoepidermoide

C) Cistadenolinfoma papilar (Tumor de Warthin) *

D) Tumor mixto maligno

Retroalimentación:

El tumor de Warthin es el segundo tumor benigno más común de la glándula parótida. Se asocia fuertemente al tabaquismo, es el tumor salival que con más frecuencia es bilateral o multicéntrico, y es el único que capta el radionúclido en la gammagrafía.

Tema: CIRUGÍA DE COLON Y RECTO

Subtema: DIVERTICULITIS AGUDA (ESCALA DE HINCHEY)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Masculino de 62 años acude por dolor intenso en la fosa ilíaca izquierda, fiebre de 38.8°C y estreñimiento. A la exploración física se detectan signos de irritación peritoneal localizados en el cuadrante inferior izquierdo. Se solicita una TAC de abdomen que reporta engrosamiento de la pared del colon sigmoides y una colección de pus (absceso) de 5 cm localizada en la pelvis, adyacente al sigmoides, sin aire libre subdiafragmático.

Pregunta 1

De acuerdo con la clasificación de Hinchey modificada por TAC para diverticulitis complicada, ¿en qué estadio se encuentra este paciente?

A) Hinchey I

B) Hinchey II *

C) Hinchey III

D) Hinchey IV

Retroalimentación:

La escala de Hinchey es vital: Estadio I (absceso pericólico localizado), Estadio II (absceso pélvico, abdominal o retroperitoneal distante), Estadio III (peritonitis purulenta generalizada) y Estadio IV (peritonitis fecaloide). Los estadios III y IV requieren cirugía de urgencia (generalmente procedimiento de Hartmann).

Pregunta 2

Para este paciente con un absceso pélvico de 5 cm (Hinchey II) que se encuentra hemodinámicamente estable, ¿cuál es el tratamiento inicial de elección según la GPC?

A) Antibioticoterapia intravenosa únicamente

B) Drenaje percutáneo guiado por imagen y antibióticos *

C) Sigmoidectomía con anastomosis primaria inmediata

D) Colonoscopia de urgencia para drenar el absceso

Retroalimentación:

Para abscesos diverticulares mayores de 5 cm, el drenaje percutáneo guiado por TAC o ultrasonido es el tratamiento inicial de elección, asociado a antibióticos de amplio espectro. Esto permite "enfriar" el proceso y realizar una cirugía programada posteriormente si es necesario.

Tema: ATLS / TRAUMA DE TÓRAX

Subtema: RUPTURA TRAUMÁTICA DE DIAFRAGMA

Dificultad: Alta

Caso clínico (Corto):

Masculino de 30 años tras trauma cerrado de abdomen y tórax por accidente automovilístico. En la radiografía de tórax se observa la presencia de niveles hidroaéreos en el hemitórax izquierdo y el paso de la sonda nasogástrica hacia el tórax.

Pregunta 1

¿En qué lado es más frecuente la ruptura diafragmática traumática y cuál es el estudio de elección para confirmar el diagnóstico cuando la radiografía es dudosa?

A) Lado derecho; Ultrasonido FAST

B) Lado izquierdo; Tomografía Computarizada (TAC) con contraste *

C) Lado izquierdo; Resonancia Magnética

D) Lado derecho; Lavado Peritoneal Diagnóstico

Retroalimentación:

La ruptura diafragmática es más frecuente del lado izquierdo (80-90%) porque el hígado protege el hemitórax derecho. La presencia de la sonda nasogástrica en el tórax es un signo clásico. El tratamiento siempre es quirúrgico por el riesgo de estrangulamiento de las vísceras herniadas.

Tema: UROLOGÍA (INFECTOLOGÍA)

Subtema: GANGRENA DE FOURNIER

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Masculino de 55 años, diabético mal controlado, acude por dolor perineal exquisito, fiebre y mal estado general. A la exploración se observa edema, coloración violácea y crepitación a la palpación en el escroto y periné, con áreas de necrosis cutánea fétida.

Pregunta 1

¿Cuál es la conducta terapéutica inmediata y más importante para salvar la vida del paciente ante este cuadro de fascitis necrotizante del periné?

A) Antibioticoterapia de amplio espectro únicamente

B) Desbridamiento quirúrgico agresivo y urgente de tejidos necróticos *

C) Curaciones locales con solución salina cada 12 horas

D) Orquiectomía bilateral

Retroalimentación:

La Gangrena de Fournier es una urgencia quirúrgica extrema. El retraso en el desbridamiento quirúrgico se asocia con una mortalidad cercana al 100%. Los antibióticos son complementarios, pero el control de la fuente (tejido necrótico) es lo prioritario.

Tema: CIRUGÍA VASCULAR

Subtema: ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL (AAA)

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Masculino de 70 años, fumador e hipertenso, acude a consulta por dolor lumbar crónico. A la exploración física de rutina se palpa una masa pulsátil en el epigastrio, por encima del ombligo. El paciente está asintomático por lo demás.

Pregunta 1

¿Cuál es el estudio de tamizaje (screening) de elección para hombres entre 65 y 75 años con antecedente de tabaquismo para detectar AAA?

A) Tomografía computarizada

B) Ultrasonido abdominal *

C) Angiografía por sustracción digital

D) Radiografía de columna lumbar

Retroalimentación:

El ultrasonido abdominal es el estudio de tamizaje inicial por su bajo costo y nula radiación. Se indica cirugía (abierta o endovascular) cuando el diámetro es >5.5 cm en hombres o >5.0 cm en mujeres, o si el crecimiento es superior a 0.5 cm en 6 meses.

Tema: CIRUGÍA GENERAL (POSTOPERATORIO)

Subtema: FIEBRE POSTQUIRÚRGICA

Dificultad: Baja

Pregunta 1

Un paciente presenta fiebre de 38.5°C en las primeras 24 horas después de una colecistectomía abierta bajo anestesia general. No tiene síntomas urinarios ni dolor en la herida. ¿Cuál es la causa más probable de fiebre en este periodo postoperatorio temprano (primeras 24-48 horas)?

A) Infección del sitio quirúrgico

B) Infección de vías urinarias

C) Atelectasia pulmonar *

D) Trombosis venosa profunda

Retroalimentación:

La atelectasia es la causa más frecuente de fiebre en las primeras 24-48 horas postquirúrgicas. Se previene y trata con ejercicios respiratorios y deambulación temprana. La infección de la herida suele aparecer después del 3er al 5to día.

Tema: CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

Subtema: CÁNCER DE TIROIDES

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Femenina de 35 años acude por presencia de un nódulo firme en el lóbulo tiroideo derecho de 1.5 cm, detectado hace 3 meses. La paciente se encuentra eutiroidea. La biopsia por aspiración con aguja fina (BAAF) reporta "Células foliculares dispuestas en estructuras papilares con cuerpos de psamoma".

Pregunta 1

¿Cuál es el tipo histológico de cáncer de tiroides más frecuente y cuál es su principal vía de diseminación?

A) Carcinoma Folicular; Vía hematógena

B) Carcinoma Papilar; Vía linfática *

C) Carcinoma Medular; Vía endocrina

D) Carcinoma Anaplásico; Extensión directa

Retroalimentación:

El carcinoma papilar es el cáncer de tiroides más común (80-85%) y tiene un excelente pronóstico. Su sello histológico son los cuerpos de psamoma y los núcleos en "ojo de la huérfana Annie". A diferencia del folicular (que viaja por sangre), el papilar se disemina principalmente a los ganglios linfáticos del cuello.

Tema: OFTALMOLOGÍA QUIRÚRGICA (URGENCIAS)

Subtema: DESPRENDIMIENTO DE RETINA

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Masculino de 50 años, con miopía elevada, acude por visión súbita de "luces" (fotopsias) y "moscas volantes" (miodesopsias) en el ojo izquierdo, seguidas de la aparición de una "cortina negra" que cubre parte de su campo visual. No refiere dolor.

Pregunta 1

Ante la sospecha de desprendimiento de retina regmatógeno, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico de elección para reaplicar la retina y cerrar el defecto?

A) Administración de corticoides intravítreos

B) Vitrectomía vía pars plana o Cerclaje escleral *

C) Fotocoagulación láser únicamente

D) Antibióticos sistémicos de amplio espectro

Retroalimentación:

El desprendimiento de retina es una urgencia oftalmológica. Los síntomas clásicos son fotopsias y miodesopsias seguidas de pérdida del campo visual. El tratamiento busca sellar la rotura mediante láser o crioterapia y reaplicar la retina mediante técnicas quirúrgicas como el cerclaje o la vitrectomía.

Tema: ATLS / TRAUMA DE TÓRAX

Subtema: LESIÓN DE GRANDES VASOS (RUPTURA DE AORTA)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Masculino de 40 años tras accidente por desaceleración brusca (choque frontal a 100 km/h). Ingresa con dolor torácico irradiado a la espalda. La radiografía de tórax muestra un ensanchamiento del mediastino (>8 cm), pérdida del contorno del botón aórtico y desviación de la tráquea a la derecha.

Pregunta 1

¿En qué sitio anatómico ocurre con mayor frecuencia la ruptura de la aorta torácica en los traumatismos cerrados por desaceleración?

A) Aorta ascendente, justo después de la válvula

B) En el istmo aórtico, distal al origen de la arteria subclavia izquierda *

C) En la aorta abdominal infrarenal

D) En el arco aórtico, entre la carótida y la subclavia

Retroalimentación:

El istmo aórtico es el punto donde la aorta está fija por el ligamento arterioso, mientras que el resto del arco es móvil; esta diferencia de movilidad causa el cizallamiento en desaceleraciones. La mayoría de los pacientes fallece en el lugar del accidente; los que llegan vivos requieren control estricto de la frecuencia cardíaca y tensión arterial antes de la reparación endovascular (TEVAR).

Tema: CIRUGÍA GENERAL

Subtema: FÍSTULAS ENTEROCUTÁNEAS

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Paciente postoperado de resección intestinal hace 7 días. Presenta salida de contenido intestinal a través de la herida quirúrgica. El gasto medido en 24 horas es de 800 ml.

Pregunta 1

De acuerdo con el volumen de gasto, ¿cómo se clasifica esta fístula enterocutánea y cuál es la prioridad inicial en su manejo?

A) Bajo gasto; Cirugía de cierre inmediato

B) Alto gasto (>500 ml); Estabilización hidroelectrolítica y control del efluente *

C) Gasto moderado; Iniciar dieta normal

D) Alto gasto; Cierre por segunda intención sin apoyo nutricional

Retroalimentación:

Las fístulas de alto gasto son aquellas con >500 ml/24h. El manejo inicial NUNCA es quirúrgico de entrada; se requiere estabilizar al paciente (líquidos), controlar la piel perilesional, suprimir el gasto (ayuno o análogos de somatostatina) y dar soporte nutricional (usualmente parenteral).

Tema: CIRUGÍA GENERAL / BIOÉTICA

Subtema: CONSENTIMIENTO INFORMADO

Dificultad: Baja

Pregunta 1

¿Cuál es la función principal del consentimiento informado antes de realizar un procedimiento quirúrgico programado?

A) Eximir al cirujano de toda responsabilidad legal por negligencia

B) Garantizar el principio de autonomía del paciente tras explicar riesgos y beneficios *

C) Asegurar que el paciente pague los honorarios médicos

D) Cumplir con un requisito puramente administrativo del hospital

Retroalimentación:

El consentimiento informado es un proceso (no solo un papel) que asegura que el paciente entiende su diagnóstico, el procedimiento propuesto, las alternativas y los riesgos posibles, permitiéndole decidir libremente sobre su cuerpo. Es una obligación ética y legal.

Tema: PATOLOGÍA BILIAR

Subtema: COLECISTITIS AGUDA (CRITERIOS DE TOKIO 2018)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Femenina de 64 años con antecedente de diabetes mal controlada. Acude por dolor en hipocondrio derecho, fiebre de 39°C y Murphy positivo. Laboratorios: Leucocitos 19,000/mm^3, Creatinina 1.8 mg/dl (basal 0.9), y una marcada respuesta inflamatoria. El ultrasonido muestra vesícula de paredes engrosadas (6 mm) con lito impactado y líquido pericolecístico.

Pregunta 1

De acuerdo con los Criterios de Tokio 2018 (TG18), ¿cuál es el grado de severidad de la colecistitis en esta paciente y cuál es la conducta terapéutica inicial recomendada?

A) Grado I (Leve); Colecistectomía laparoscópica temprana

B) Grado II (Moderada); Antibióticos y colecistectomía en 6 semanas

C) Grado III (Grave); Estabilización y drenaje de vesícula (colecistostomía) *

D) Grado III (Grave); Colecistectomía abierta de urgencia inmediata

Retroalimentación:

La paciente presenta un Grado III (Severo) debido a la disfunción orgánica (falla renal aguda con elevación de creatinina y leucocitosis >18,000). Según TG18, en Grado III la prioridad es estabilizar el fallo orgánico; si no mejora o está muy crítica, el drenaje de la vesícula (colecistostomía percutánea) es el paso inicial antes de pensar en una cirugía definitiva.

Tema: ENFERMEDAD DIVERTICULAR

Subtema: DIVERTICULITIS AGUDA (ESCALA DE HINCHEY)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Corto):

Masculino de 58 años acude por dolor en fosa ilíaca izquierda y fiebre. La TAC de abdomen reporta diverticulitis en sigmoides asociada a una colección de material purulento no tabicado que se extiende por toda la cavidad abdominal (peritonitis generalizada). No se observa salida de material fecaloide ni aire libre subdiafragmático masivo.

Pregunta 1

Utilizando la clasificación de Hinchey, ¿en qué estadio se encuentra este paciente y cuál es el tratamiento quirúrgico de elección?

A) Hinchey II; Drenaje percutáneo

B) Hinchey III; Procedimiento de Hartmann o lavado laparoscópico *

C) Hinchey IV; Anastomosis primaria con estoma de protección

D) Hinchey I; Antibióticos ambulatorios

Retroalimentación:

Hinchey III se define como peritonitis purulenta generalizada. El manejo clásico es el Procedimiento de Hartmann (sigmoidectomía + colostomía terminal), aunque en centros seleccionados se puede intentar lavado laparoscópico. El Hinchey IV (peritonitis fecaloide) siempre requiere Hartmann.

Tema: ATLS / TRAUMA DE CUELLO

Subtema: ZONAS ANATÓMICAS DE MONSON

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Masculino de 25 años ingresa con herida penetrante por arma blanca en el cuello, localizada por debajo del cartílago cricoides, justo por encima de la escotadura esternal y las clavículas. El paciente tiene enfisema subcutáneo y un pequeño hematoma en expansión.

Pregunta 1

¿En qué zona anatómica del cuello se localiza la lesión y cuál es el riesgo principal asociado a esta zona debido a la dificultad de abordaje quirúrgico?

A) Zona I; Lesión de grandes vasos mediastínicos y cúpula pleural *

B) Zona II; Lesión de laringe y esófago cervical

C) Zona III; Lesión de la arteria carótida distal y pares craneales

D) Zona II; Lesión de la glándula tiroides únicamente

Retroalimentación:

La Zona I comprende la base del cuello (desde clavículas/esternón hasta cricoides). Es la zona con mayor mortalidad porque alberga los grandes vasos que salen del tórax y es difícil de explorar sin realizar una esternotomía. La Zona II (cricoides a ángulo mandíbula) es la más fácil de explorar.

Tema: UROLOGÍA (ONCOLOGÍA)

Subtema: QUISTES RENALES (CLASIFICACIÓN DE BOSNIAK)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Corto):

Se realiza una TAC a un paciente de 50 años por dolor lumbar. Se identifica un quiste renal derecho de 4 cm que presenta múltiples tabiques finos en su interior y algunas calcificaciones lineales en la pared. Tras la administración de contraste, no hay un realce significativo de los tabiques.

Pregunta 1

De acuerdo con la clasificación de Bosniak para quistes renales detectados por TAC, ¿en qué categoría entra esta lesión y cuál es la conducta recomendada?

A) Bosniak I; Benigno, no requiere seguimiento

B) Bosniak II; Benigno, seguimiento radiológico *

C) Bosniak III; Probable malignidad, nefrectomía parcial

D) Bosniak IV; Maligno, nefrectomía radical

Retroalimentación:

Bosniak II describe quistes con tabiques finos o mínimas calcificaciones que no realzan. Son considerados benignos pero requieren seguimiento. Los Bosniak III y IV tienen un riesgo de malignidad del 50% y >90% respectivamente, por lo que su manejo suele ser quirúrgico.

Tema: QUEMADURAS

Subtema: QUEMADURA ELÉCTRICA Y MIOGLOBINURIA

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Trabajador de la construcción de 30 años sufre descarga de alta tensión (13,000 voltios). Presenta herida de entrada en mano derecha y salida en pie izquierdo. En urgencias, su orina se observa de coloración oscura (color "coca-cola").

Pregunta 1

Ante la sospecha de rabdomiólisis por quemadura eléctrica de alta tensión, ¿cuál es la meta de diuresis horaria que debe mantenerse mediante la reanimación hídrica agresiva para prevenir la insuficiencia renal aguda?

A) 0.5 ml/kg/hr

B) 1.0 a 1.5 ml/kg/hr *

C) 3.0 ml/kg/hr

D) 0.3 ml/kg/hr

Retroalimentación:

En quemaduras eléctricas con mioglobinuria (orina oscura), la meta de diuresis es mayor (1-1.5 ml/kg/hr en lugar de los 0.5 ml/kg/hr de quemaduras térmicas). Esto sirve para "lavar" la mioglobina de los túbulos renales. Además, se puede considerar la alcalinización de la orina con bicarbonato.

Tema: MEDICINA INTERNA / INFECTOLOGÍA

Subtema: CHOQUE SÉPTICO (DEFINICIÓN SEPSIS-3)

Dificultad: Alta

Caso clínico (Medio):

Masculino de 65 años, hospitalizado por neumonía adquirida en la comunidad. Presenta deterioro clínico con TA de 70/40 mmHg. A pesar de una adecuada reanimación hídrica con 30 ml/kg de cristaloides, la hipotensión persiste. Se inician vasopresores (norepinefrina) y se toman laboratorios de control que reportan un lactato sérico de 3.5 mmol/L.

Pregunta 1

De acuerdo con el Consenso Internacional Sepsis-3, ¿cuáles son los criterios clínicos y bioquímicos exactos que definen el estado actual de choque séptico en este paciente?

A) Hipotensión refractaria a líquidos que requiere vasopresores para mantener una PAM ≥ 65 mmHg, acompañada de un nivel de lactato sérico > 2 mmol/L *

B) Presencia de 2 o más criterios de SIRS (respuesta inflamatoria sistémica) más un foco infeccioso documentado

C) Caída de la presión arterial sistólica < 90 mmHg con procalcitonina positiva

D) Alteración del estado mental, taquipnea > 22 rpm y lactato > 4 mmol/L

Retroalimentación:

El consenso Sepsis-3 eliminó los criterios de SIRS para definir sepsis. El choque séptico se define estrictamente como la subcategoría de la sepsis en la que las alteraciones circulatorias y del metabolismo celular son lo suficientemente profundas como para aumentar sustancialmente la mortalidad. Clínicamente se identifica por la necesidad de vasopresores para mantener una PAM ≥ 65 mmHg Y un lactato > 2 mmol/L (18 mg/dL) a pesar de una reanimación hídrica adecuada.

Tema: MEDICINA INTERNA / INFECTOLOGÍA

Subtema: TUBERCULOSIS PULMONAR (EFECTOS ADVERSOS DEL TAES)

Dificultad: Media

Caso clínico (Corto):

Femenina de 40 años, recién diagnosticada con tuberculosis pulmonar (BAAR positivo en esputo). Inicia tratamiento acortado estrictamente supervisado (TAES) con la fase intensiva de 4 fármacos (Isoniazida, Rifampicina, Pirazinamida y Etambutol). A las 3 semanas de tratamiento, acude refiriendo visión borrosa y dificultad para distinguir los colores rojo y verde.

Pregunta 1

¿Cuál de los fármacos antituberculosos de primera línea es el responsable clásico de este efecto adverso ocular (neuritis óptica retrobulbar)?

A) Isoniazida

B) Rifampicina

C) Pirazinamida

D) Etambutol *

Retroalimentación:

El Etambutol tiene como toxicidad principal la neuritis óptica, la cual es dosis-dependiente. Se manifiesta clásicamente con disminución de la agudeza visual, escotomas centrales y discromatopsia (pérdida de la discriminación de los colores rojo-verde). La Isoniazida causa neuropatía periférica (se previene con piridoxina), la Rifampicina tiñe las secreciones de color naranja y la Pirazinamida causa hiperuricemia (gota).

Tema: MEDICINA INTERNA / INFECTOLOGÍA

Subtema: VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (INFECCIONES OPORTUNISTAS)

Dificultad: Media

Caso clínico (Medio):

Masculino de 32 años con diagnóstico reciente de infección por VIH, sin tratamiento antirretroviral previo. Su recuento de CD4 es de 120 células/mm^3. Acude por cuadro subagudo (3 semanas de evolución) de tos seca, fiebre no cuantificada y disnea progresiva que empeora notablemente al esfuerzo. En la gasometría se evidencia hipoxemia severa. La radiografía de tórax muestra un infiltrado intersticial bilateral difuso "en vidrio despulido" de predominio perihiliar. Sus niveles de deshidrogenasa láctica (LDH) están marcadamente elevados.

Pregunta 1

Ante la sospecha del agente oportunista pulmonar más frecuente en pacientes con VIH y CD4 < 200, ¿cuál es el tratamiento antimicrobiano de primera elección?

A) Fluconazol intravenoso

B) Ceftriaxona más Azitromicina

C) Trimetoprima-Sulfametoxazol (TMP-SMX) a dosis altas *

D) Ganciclovir intravenoso

Retroalimentación:

El cuadro clínico subagudo, la hipoxemia, la elevación de LDH y el patrón en "vidrio despulido" en un paciente con CD4 < 200 células/mm^3 son patognomónicos de neumonía por Pneumocystis jirovecii (PCP). El tratamiento y la profilaxis de elección es el Trimetoprima-Sulfametoxazol. Si la PaO2 es < 70 mmHg, se deben agregar corticosteroides sistémicos antes de iniciar el antibiótico para evitar el empeoramiento de la hipoxemia por la inflamación producida al destruir el hongo.

Tema: MEDICINA INTERNA / INFECTOLOGÍA

Subtema: ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Femenina de 25 años, residente de zona endémica, cursa con su cuarto día de enfermedad por Dengue. Acude a urgencias porque la fiebre ha cedido (afebril en las últimas 12 horas), pero inició súbitamente con dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes y letargo. Sus laboratorios muestran un aumento repentino del hematocrito con caída rápida de las plaquetas.

Pregunta 1

La desaparición de la fiebre marca el inicio de una nueva fase en el Dengue. La presencia de dolor abdominal intenso y hemoconcentración sugiere que la paciente ha entrado en la fase crítica. ¿Cuál es la alteración fisiopatológica principal de esta fase que pone en riesgo inminente la vida del paciente?

A) Replicación viral masiva en el sistema nervioso central

B) Falla hepática fulminante por necrosis directa

C) Extravasación severa de plasma por aumento de la permeabilidad capilar *

D) Hemólisis autoinmune masiva

Retroalimentación:

En el curso clínico del Dengue, la fase crítica (que dura de 24 a 48 horas) ocurre frecuentemente coincidiendo con la defervescencia (caída de la fiebre). Los signos de alarma (dolor abdominal, vómitos, letargo) indican una fuga capilar severa. La complicación que mata al paciente en esta fase es el choque hipovolémico distributivo secundario a la extravasación masiva de plasma.

[Image of Dengue clinical course phases]

Tema: MEDICINA INTERNA / NEUMOLOGÍA

Subtema: ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)

Dificultad: Baja

Caso clínico (Corto):

Masculino de 68 años, con índice tabáquico de 45 paquetes/año. Acude por disnea progresiva de grandes a medianos esfuerzos y tos productiva matutina de años de evolución. Se sospecha de EPOC y se le solicita una espirometría con broncodilatador para confirmar el diagnóstico.

Pregunta 1

¿Cuál es el criterio espirométrico de la iniciativa GOLD que establece el diagnóstico definitivo de limitación irreversible del flujo aéreo (EPOC)?

A) Capacidad Vital Forzada (CVF) menor al 80% del predicho

B) Relación VEF1/CVF menor de 0.70 post-broncodilatador *

C) Volumen Espiratorio Forzado en el primer segundo (VEF1) menor de 0.80 post-broncodilatador

D) Reversibilidad del VEF1 mayor al 12% tras el uso de Salbutamol

Retroalimentación:

El diagnóstico espirométrico de EPOC requiere demostrar una obstrucción al flujo aéreo que NO es totalmente reversible. Esto se define universalmente por una relación VEF1/CVF (Índice de Tiffeneau-Pinelli) < 0.70 (o 70%) DESPUÉS de administrar un broncodilatador. Una reversibilidad significativa (>12% y >200 ml) orientaría hacia asma.